



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

FACULTÉ DE MÉDECINE



**Hôpitaux
Universitaires
Genève**

La démarche clinique en dermatologie

Prof. G. KAYA, M.D.-Ph.D.

Unité de Dermatopathologie

Service de Dermatologie

Les démarches cliniques diagnostiques en dermatologie :

- la reconnaissance globale
- la sémiologie : l'analyse des signes

La reconnaissance globale

moineau

SPARROW



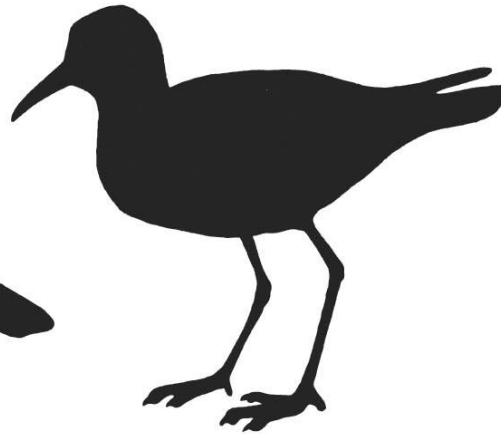
rouge-gorge

ROBIN



bécasseau

SANDPIPER



pic

WOODPECKER

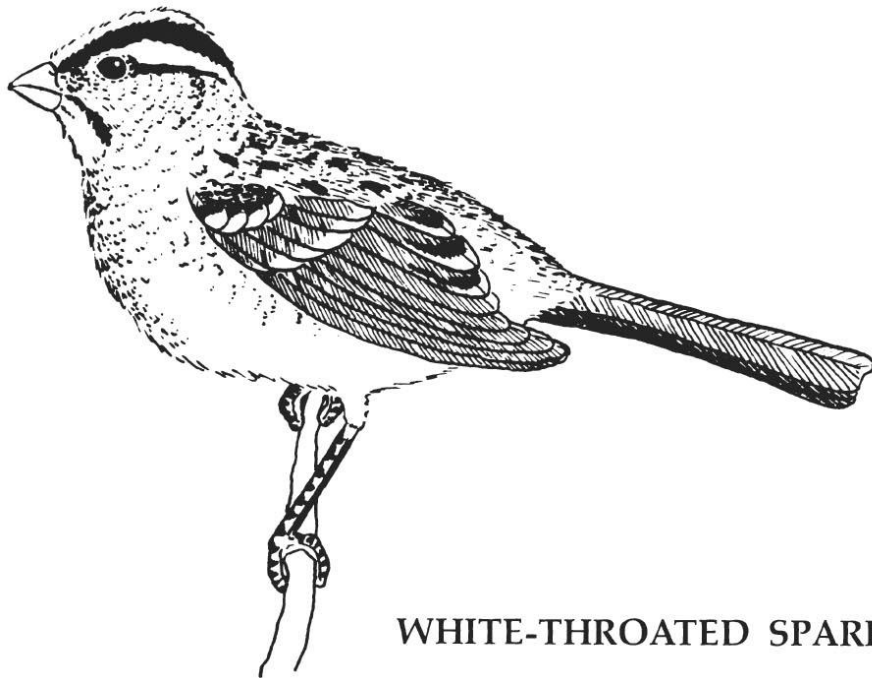


fauvette

WARBLER



L'analyse des signes



WHITE-THROATED SPARROW

bruant à gorge blanche



SONG SPARROW

bruant chanteur

Examen clinique

L'examen d'un patient porteur d'une dermatose

La peau est un organe différent des autres :

C'est un organe visible

C'est un organe d'échange

C'est un organe affiché

La peau est un organe accessible à l'examen clinique et aux explorations paracliniques simples (prélèvement, biopsie). L'observation de la peau, des muqueuses et des phanères fait partie de tout examen clinique

Les conseils pratiques pour bien examiner

La *démarche rapide*, qui fait le diagnostic dès la salle d'attente : au premier coup d'oeil on a reconnu une maladie particulière sur un symptôme caractéristique : eczéma, angiome...

La *méthode raisonnée* est plus lente. Elle a recours à une démarche médicale classique: le recueil de données (l'analyse) précède le diagnostic (la synthèse). C'est cette méthode qui est utilisée et sert de trame à l'examen clinique.

Le recueil des données

Basé sur le déroulement habituel d'une consultation, le recueil des symptômes comporte les étapes successives suivantes:

- 1- L'interrogatoire du patient (ou de l'entourage chez l'enfant)
- 2- L'examen des lésions
- 3- L'enquête anamnétique plus orientée
- 4- L'examen complet du patient

1- L'interrogatoire de base :

L'interrogatoire tente de préciser 2 points principaux :

- *L'histoire récente et les motifs de la consultation.* L'aspect initial rapporté par le patient est en général imprécis et il ne faut pas attendre du malade une description sémiologique fine et encore moins un diagnostic. Par contre, le point de départ des lésions, les circonstances de la survenue, la notion d'épidémie sont des notions utiles.
- *Les modalités évolutives de l'éruption.* Leur caractère aiguë ou chronique, les thérapeutiques appliquées seront systématiquement demandées.

2- L'examen des lésions :

Le médecin doit s'imposer des **conditions d'examen rigoureuses** : le diagnostic d'inspection rapide n'a aucune fiabilité. Le patient, détendu, doit être examiné dans un endroit **correctement éclairé** ; l'ensemble du revêtement cutané est analysé : cheveux, ongles, muqueuses, régions ano-génitales, ombilic, plis rétro-auriculaires, paumes et plantes. Certains accessoires sont utiles : la loupe, le verre de montre, l'abaisse langue, la lampe frontale par exemple. L'examen à la lumière de Wood est très utile.

Quelle lésion analyser ?

Devant une éruption plus ou moins polymorphe, le médecin sera interloqué sur quelle lésion son œil doit-il s'arrêter ?

L'analyse clinique d'une éruption oblige à une sélection. Certaines lésions sont en effet très discriminantes.

Synthèse clinique systématique

1. Lésion élémentaire

LESIONS ELEMENTAIRES

PRIMITIVES

Correspondent au processus pathologique initial

SECONDAIRES

Correspondent à l'évolution du processus pathologique

Comment reconnaître les lésions élémentaires ?

Est-ce que la lésion est palpable ?

- Non : Macule

- Oui : solide :

- Papule <1cm

- Plaque >1cm

- Nodule (>1cm) / Tumeur (>2cm) / Nouures (>5 cm à extension hypodermique / ou Gommès (si ramolissement et ulcération secondaire)

- Végétation (excroissance molle à surface érosive)

- Verrucosités (végétation à surface cornée hyperkératosique)

- Cordon (+ palpable que visible en forme de corde linéaire)

- Sillon (petit tunnel qui héberge habituellement un parasite)

- Oui : liquide : 1-vésicule (<3mm) 2-bulle (>5mm) 3-pustule

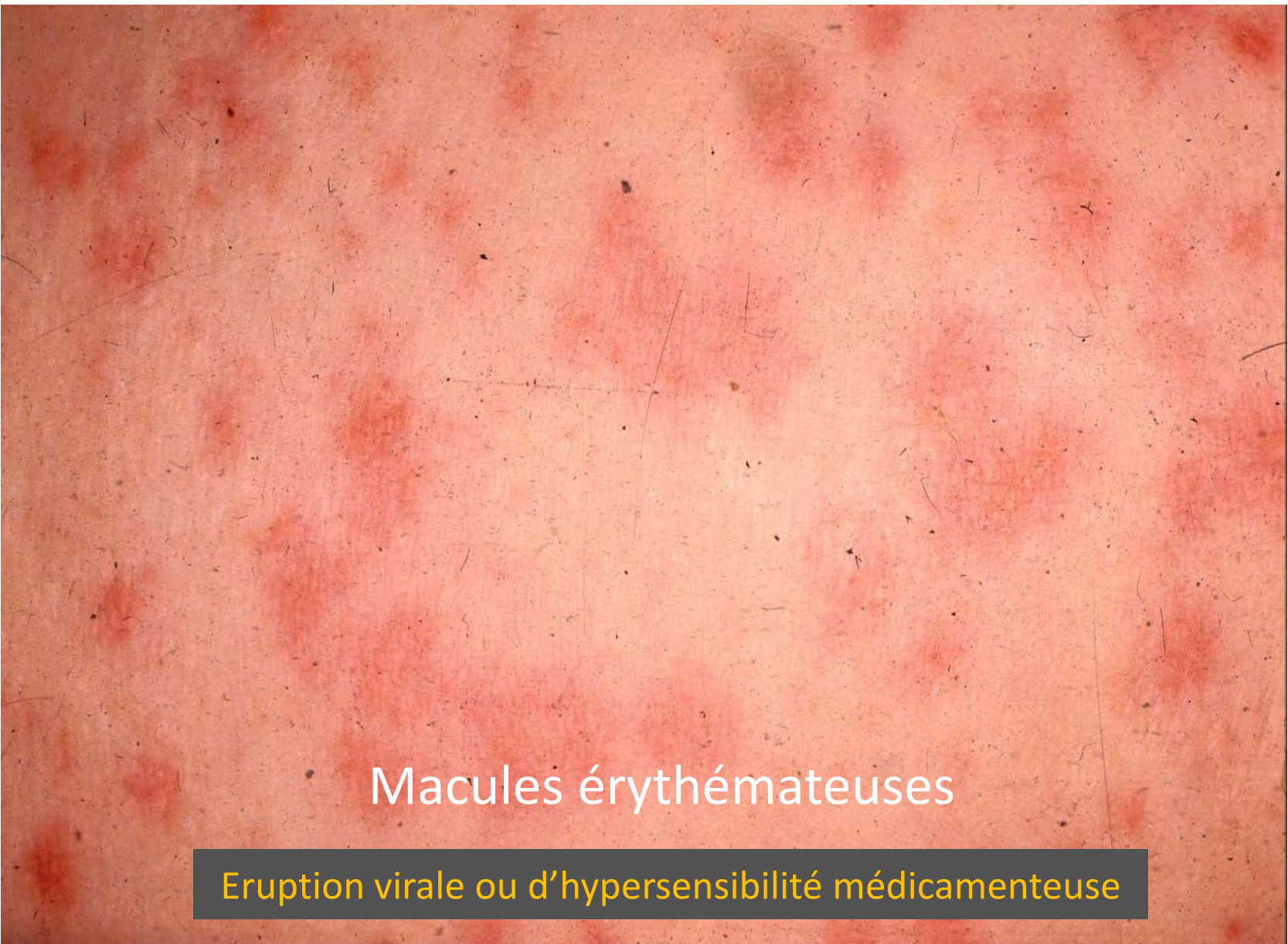
LESIONS ELEMENTAIRES

PRIMITIVES

Correspondent au processus
pathologique initial

Macules

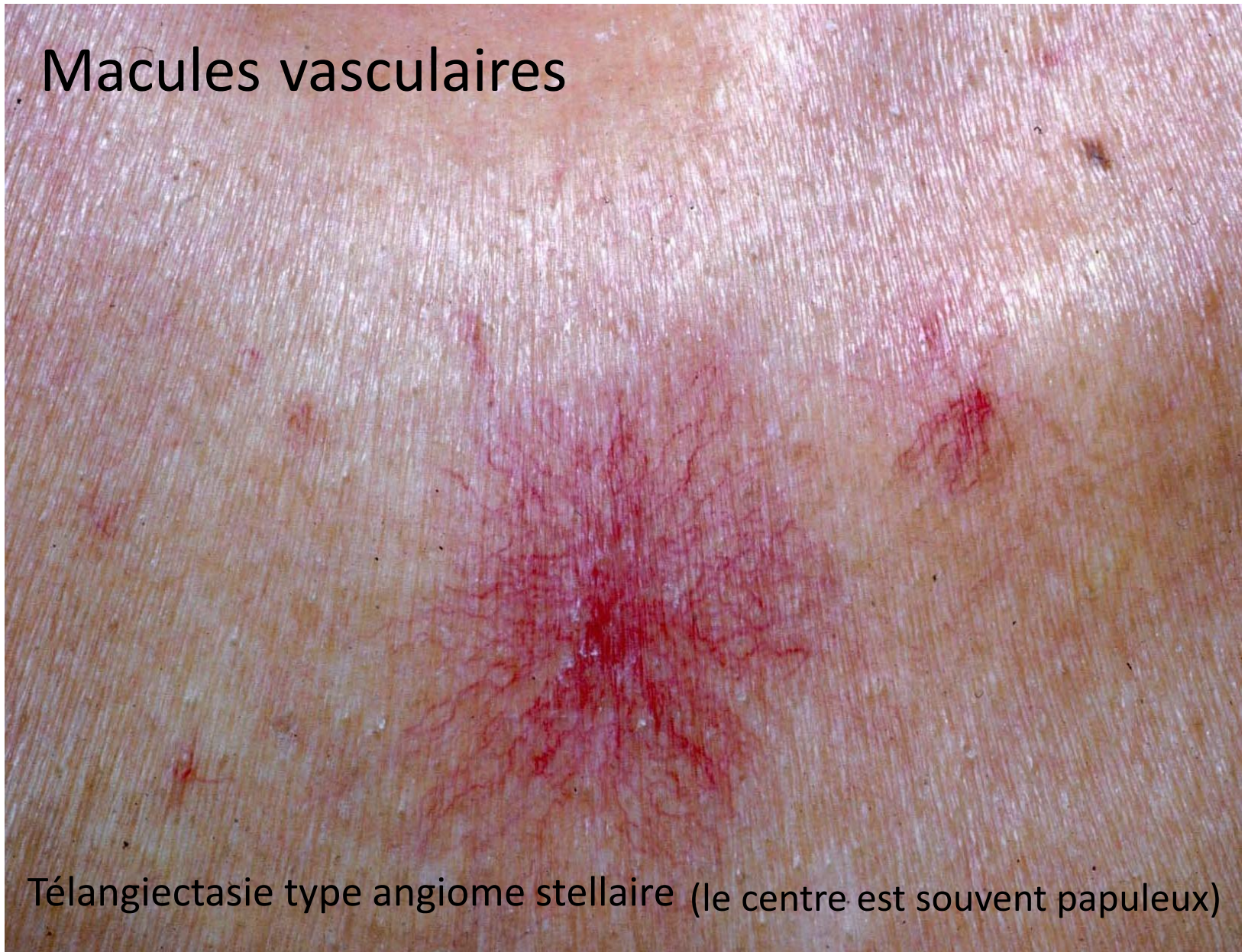
- érythémateuses
- vasculaires
- purpuriques
- achromiques
- pigmentaires



Macules érythémateuses

Eruption virale ou d'hypersensibilité médicamenteuse

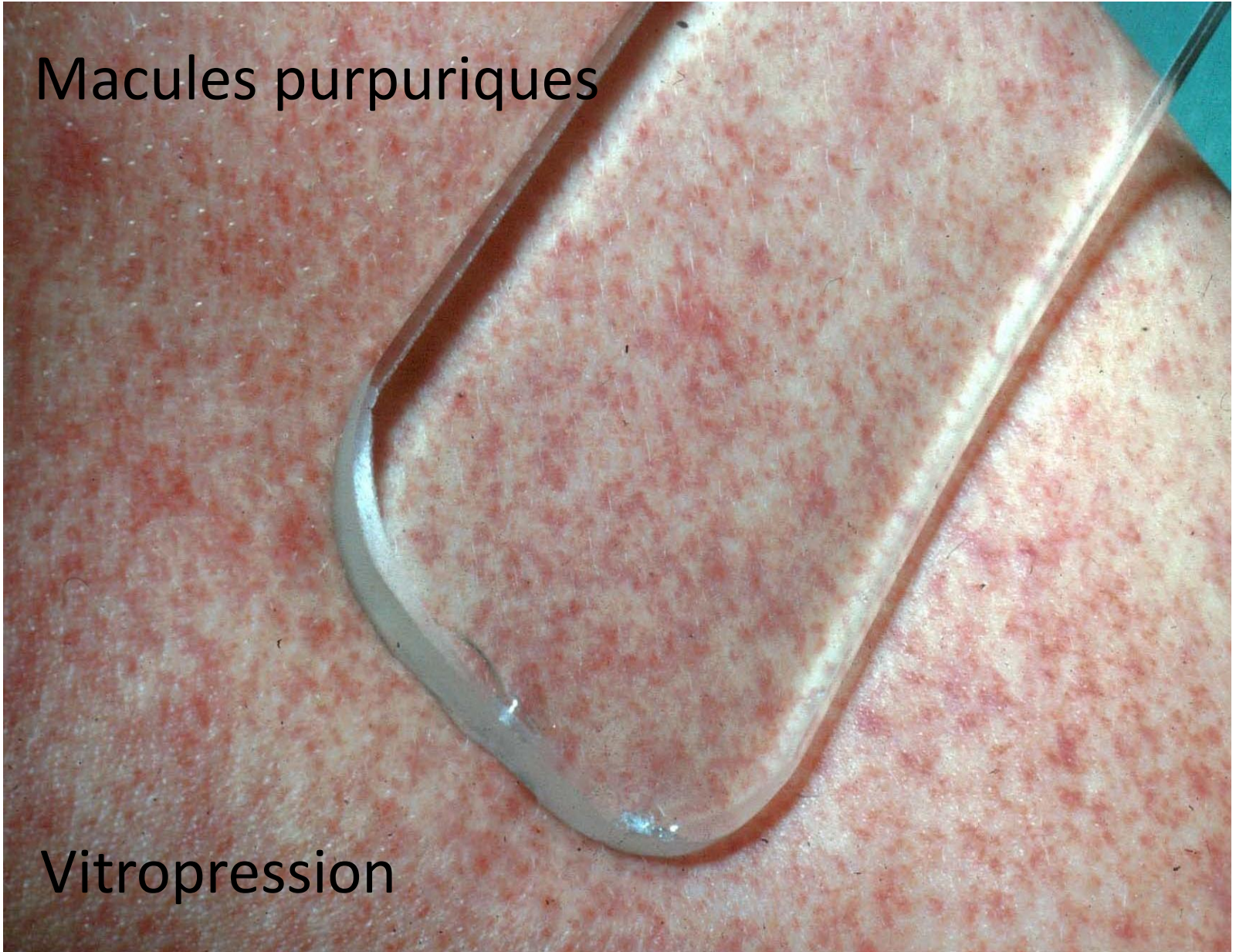
Macules vasculaires

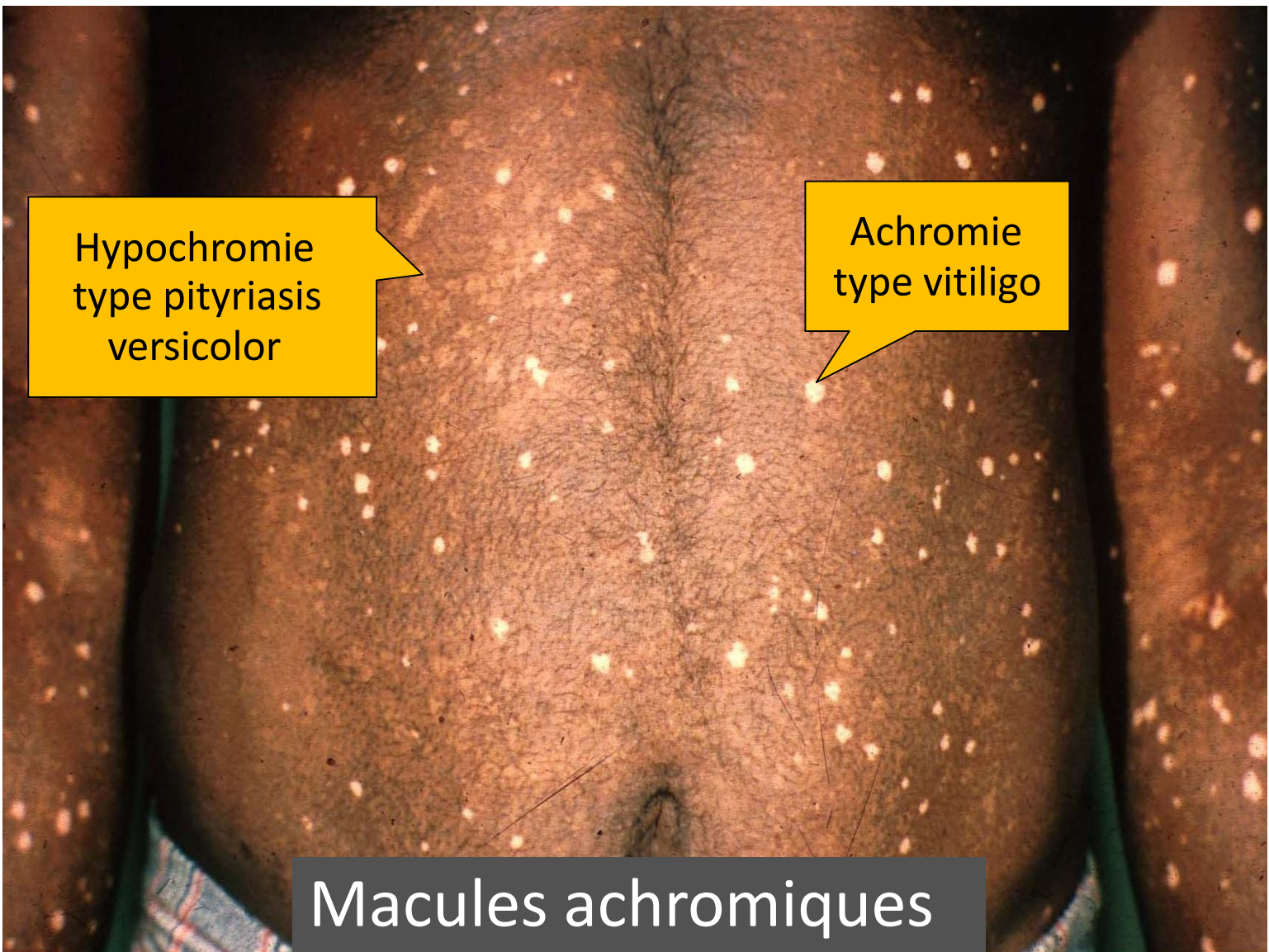


Télangiectasie type angiome stellaire (le centre est souvent papuleux)

Macules purpuriques

Vitropression





Hypochromie
type pityriasis
versicolor

Achromie
type vitiligo

Macules achromiques



Macules pigmentaires épidermiques
Lentigos solaires



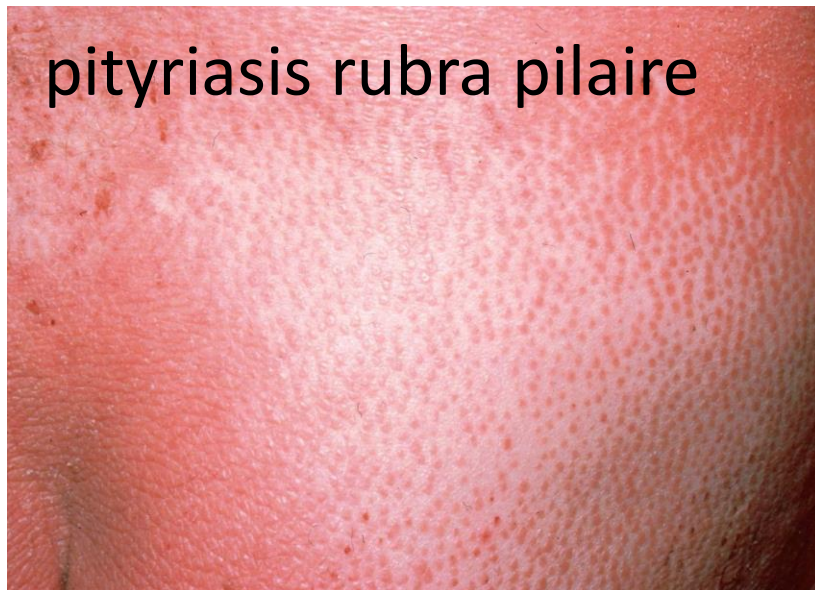
Macules pigmentaires dermiques

Érythème pigmenté fixe = Réaction allergique à un médicament

Papules

- Épidermiques
 - folliculaire
 - non-folliculaire
- Dermiques
 - œdème
 - cellules
 - dépôts matrice extracellulaire
 - purpuriques

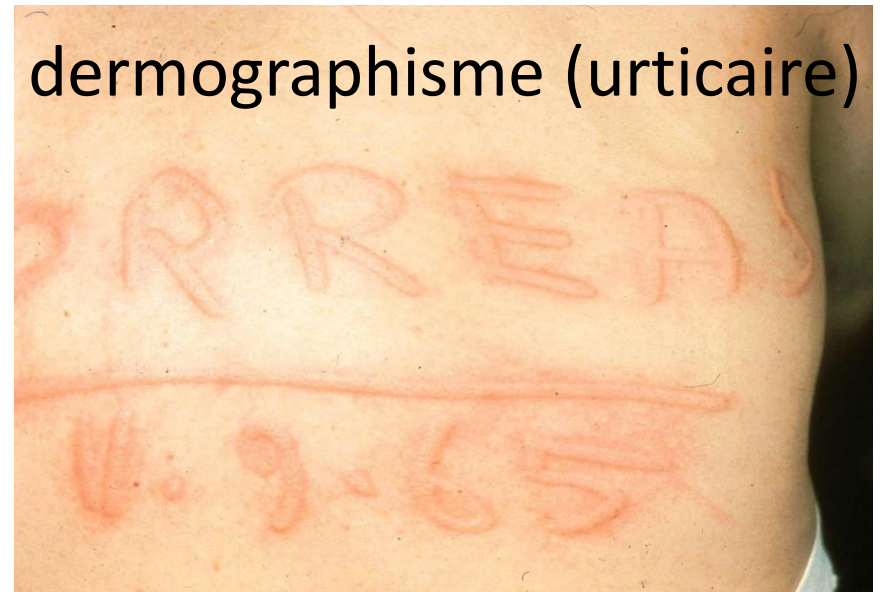
Papules épidermiques folliculaires



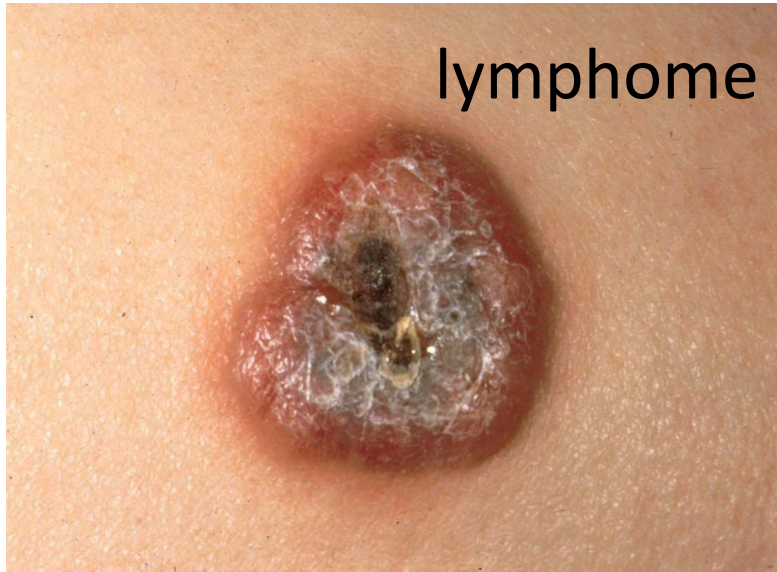
Papules épidermiques non-folliculaires



Papules dermiques causées par un oedème



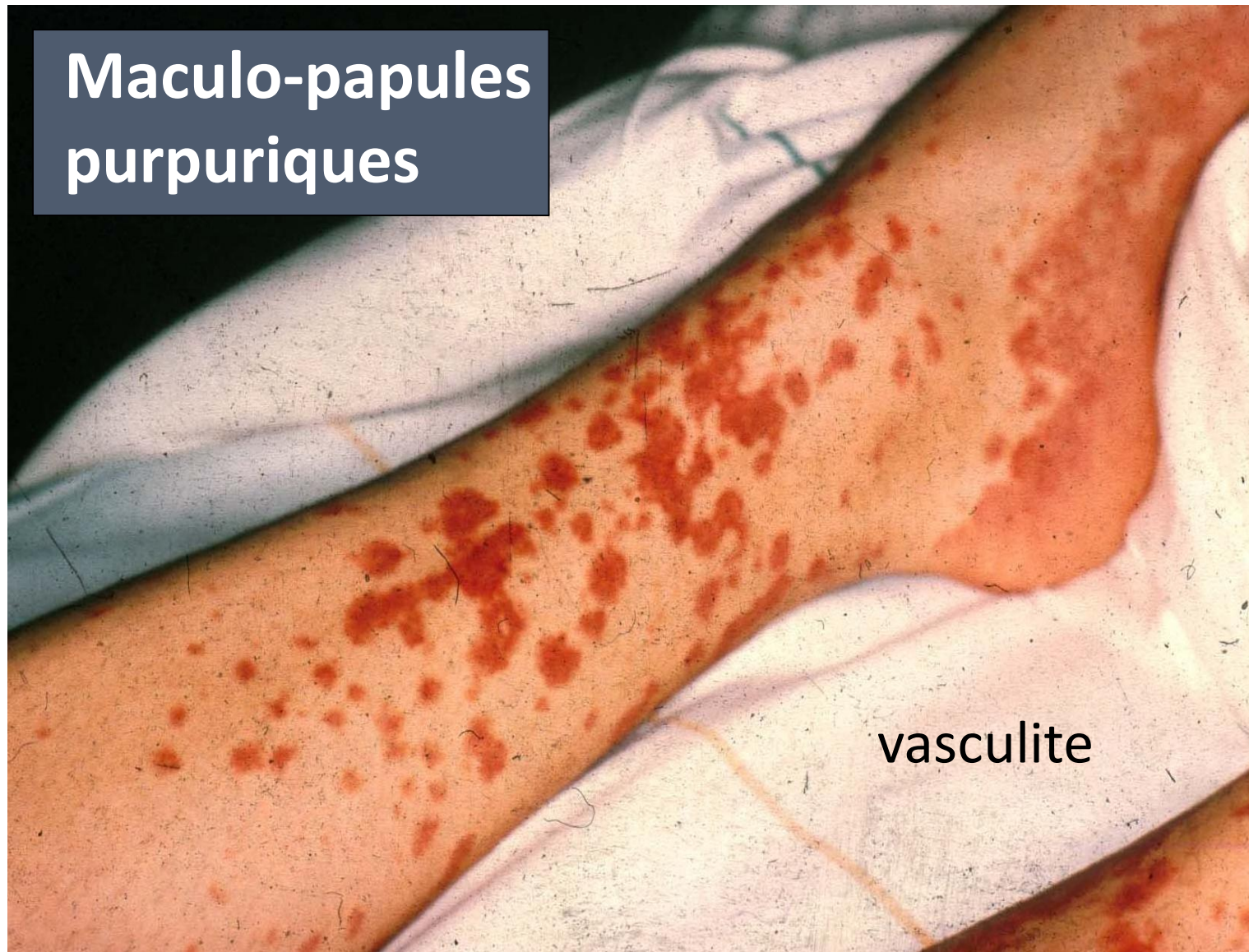
Papules dermiques causée par infiltrat cellulaire



Papules dermiques causée par surcharge cellulaire



**Maculo-papules
purpuriques**



vasculite

psoriasis

Papule mixte
Hyperplasie épidermique (acanthose)
et infiltrat cellulaire dermique
inflammatoire





Nodule



Tumeur



Nouures



Gomme



Végétation



Verrucosité



Cordon



Sillon

Vésicules



Vésicules

Bulles sous-épidermiques

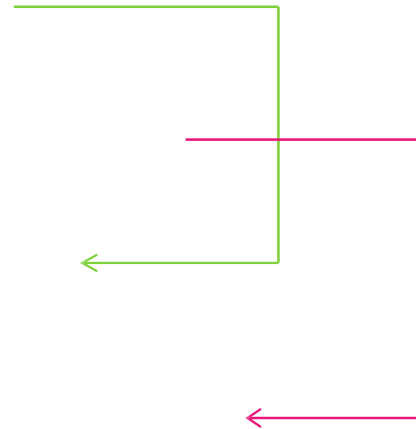


Bulles intra-épidermiques



Pustules

- Folliculaires
- Non folliculaires
- Infectieuses
- Non infectieuses





Pustules folliculaires
(épilation à la cire...)



Pustules non folliculaires
(psoriasis pustuleux)

LESIONS ELEMENTAIRES

PRIMITIVES

Correspondent au processus pathologique initial

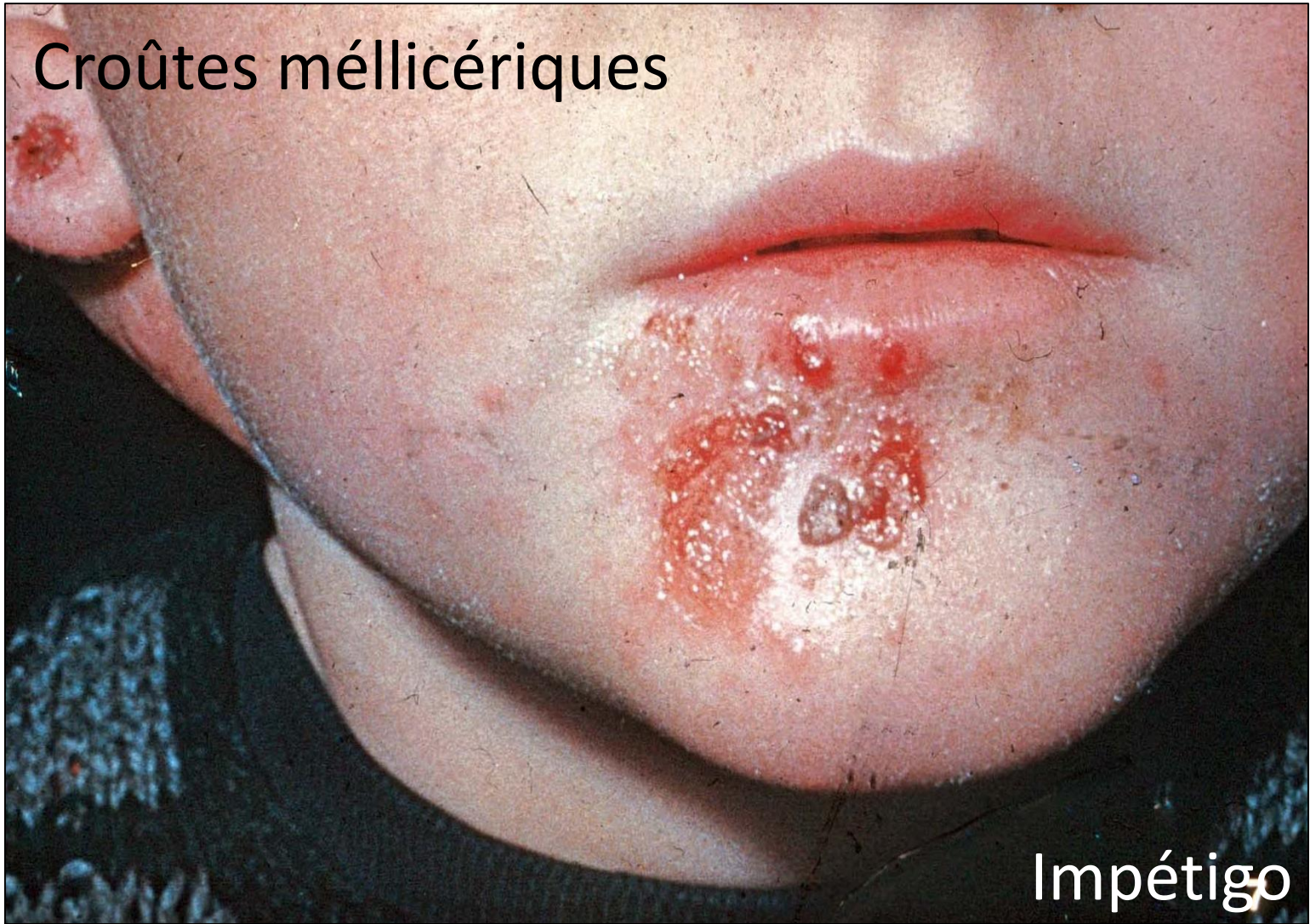
SECONDAIRES

Correspondent à l'évolution du processus pathologique

LESIONS ELEMENTAIRES SECONDAIRES

- Croûtes
- Squames
- Excoriations
- Fissures (rhagades)

Croûtes mélicériques



Impétigo

Croûte de pustules

Psoriasis pustuleux

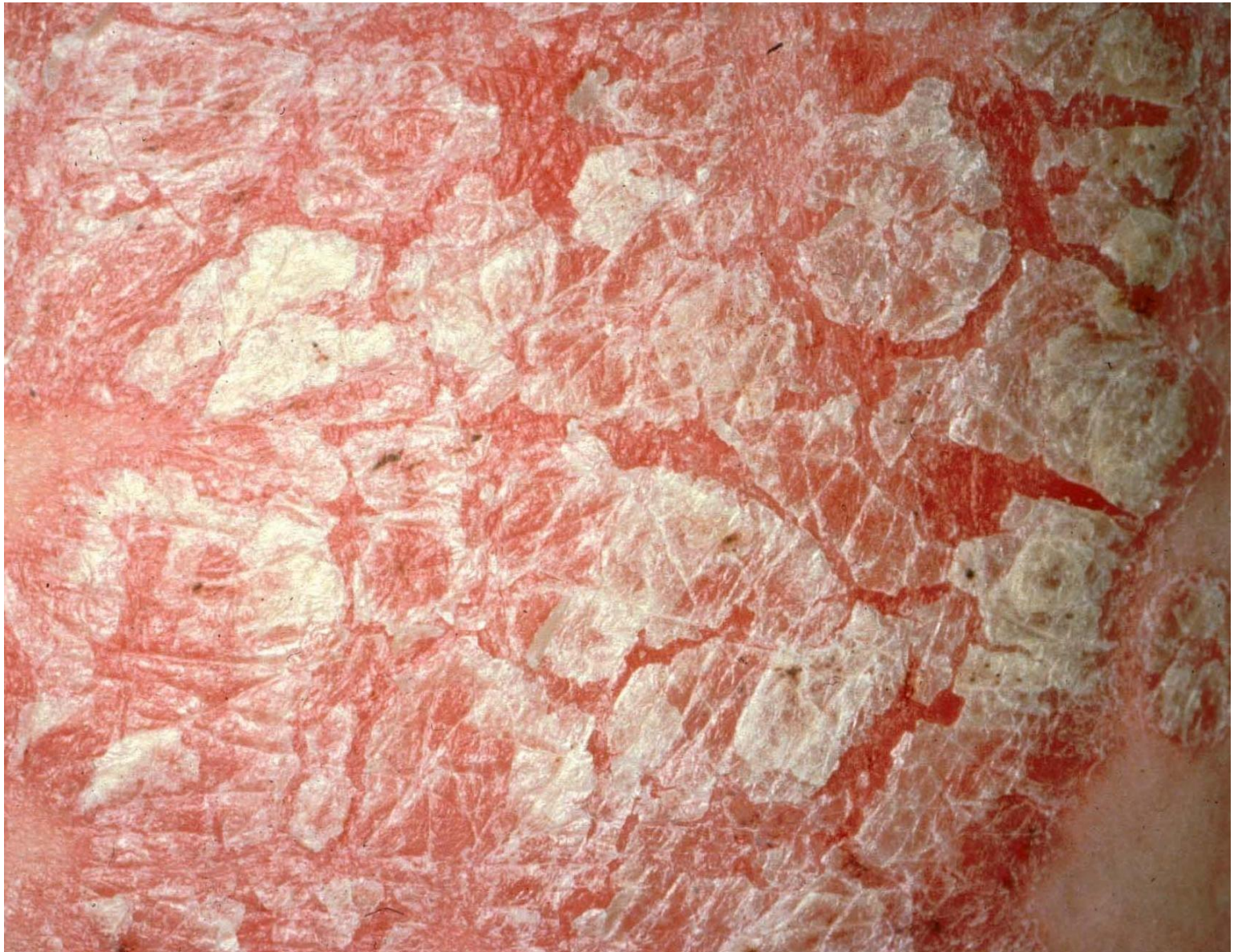




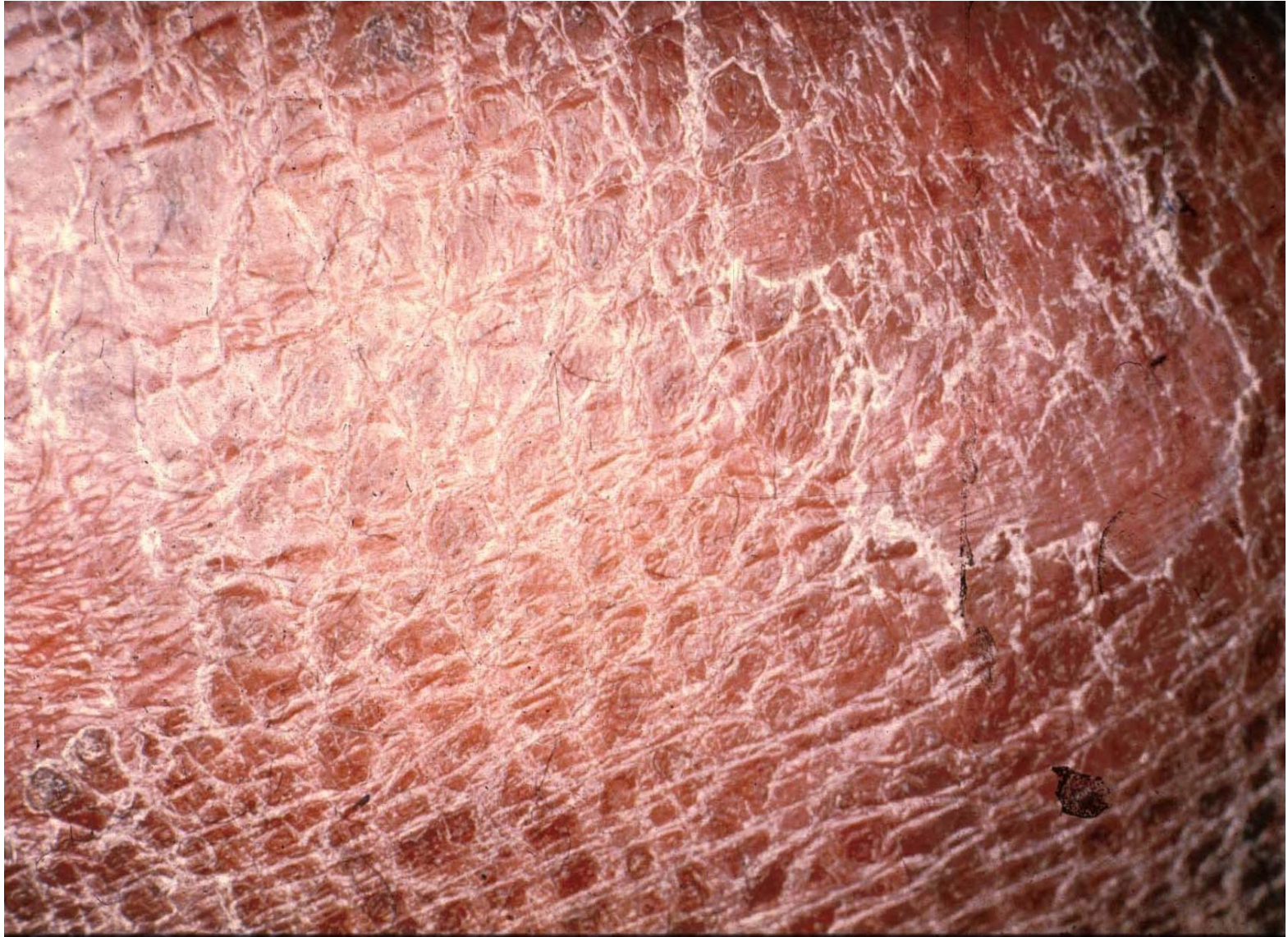
Squames scarlatiniformes
Desquamation « en doigt de gant »



Squames scarlatiniformes
Desquamation « en lambeaux »



Squames psoriasiformes



Squames ichtyosiformes (en écaille)
Ichtyose congénitale



Squames pityriasiformes (comme des p  licules)
Pityriasis versicolor

Excoriations



Dermatite atopique

Excoriations et fissures



Dermatite atopique

Fissure



Eczéma chronique de jambe

Fissure



Pulpite d'eczéma de contact



Ulcère

Ulcère gangréneux



Synthèse clinique systématique

1. Lésion élémentaire

2. Groupement

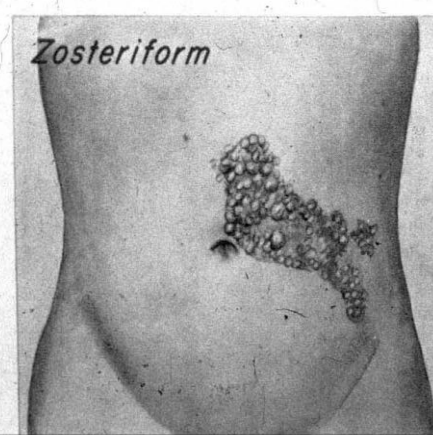
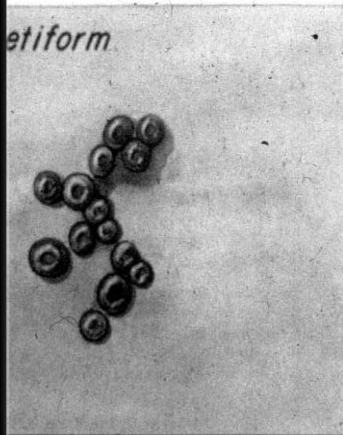
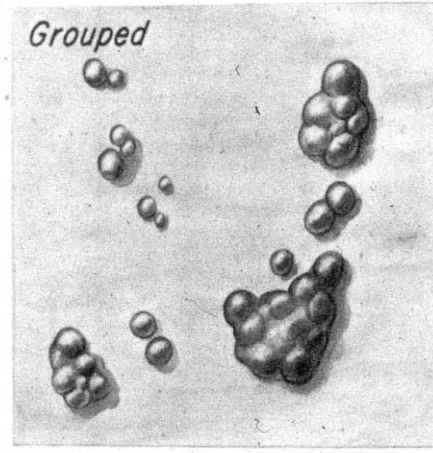
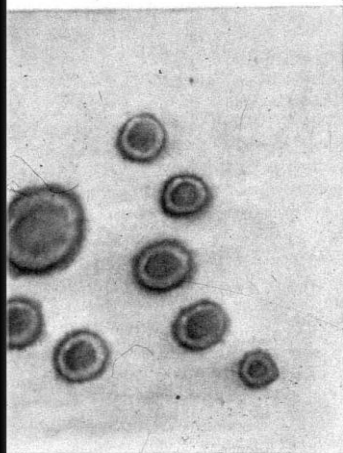
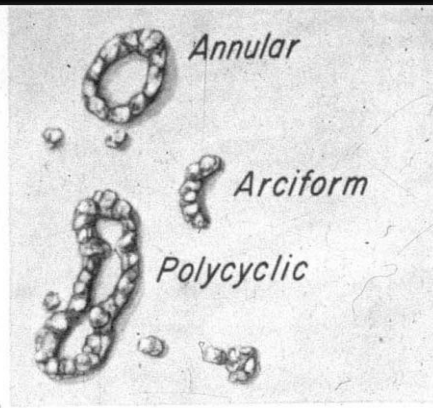
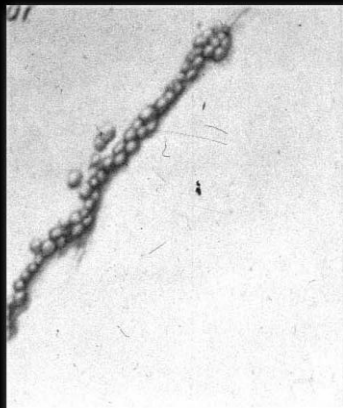
GROUPEMENT

La forme des lésions

Arrondie, ovale, polygonale, polycyclique, annulaire (en forme d'anneau), serpentineuse (sinueuse)

La disposition des lésions

Isolées, distinctes ou bien au contraire groupées : en bande (zoniforme), en bouquet (herpétiforme), en filet (réticulé), en arc de cercle (arciforme)

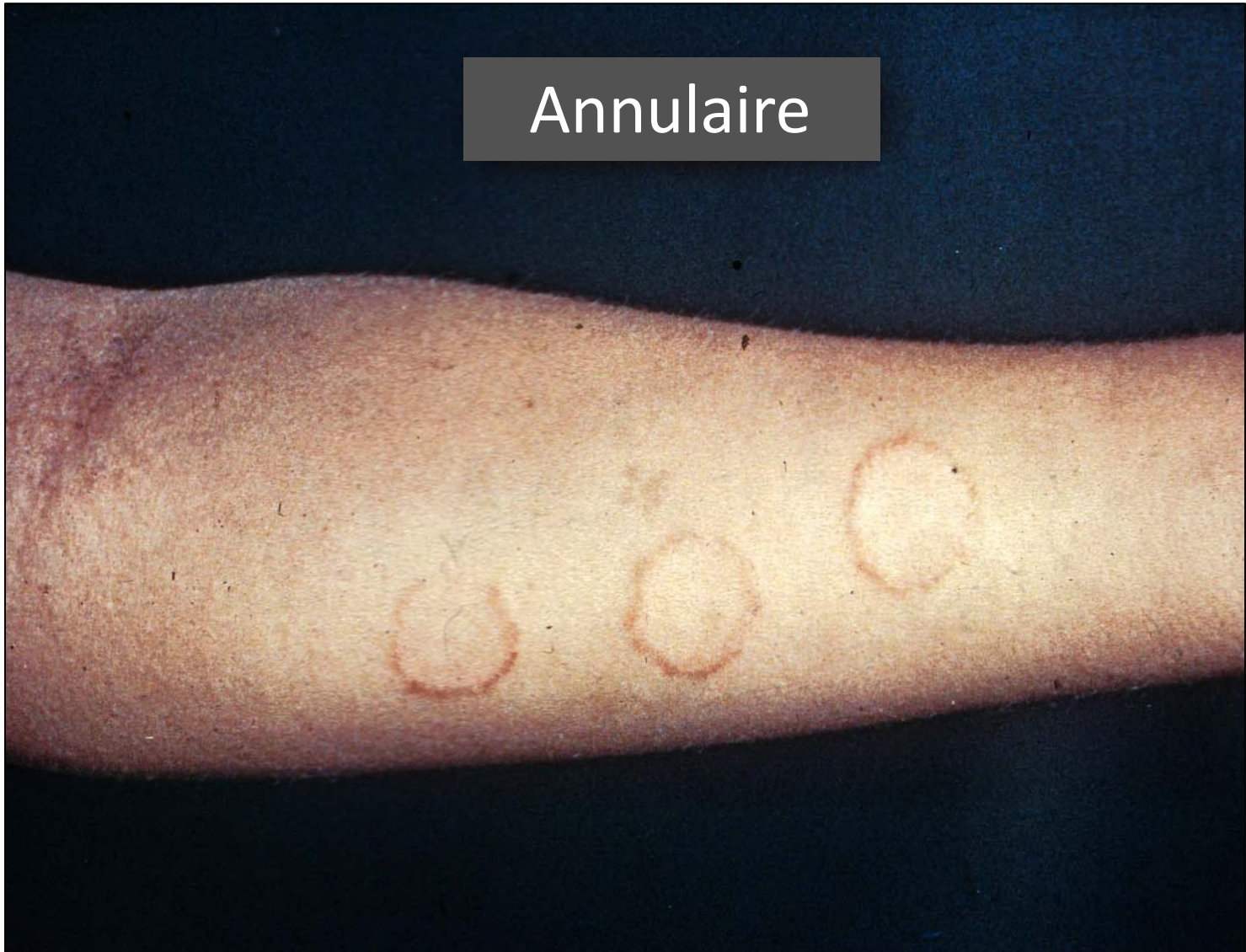


Plaques

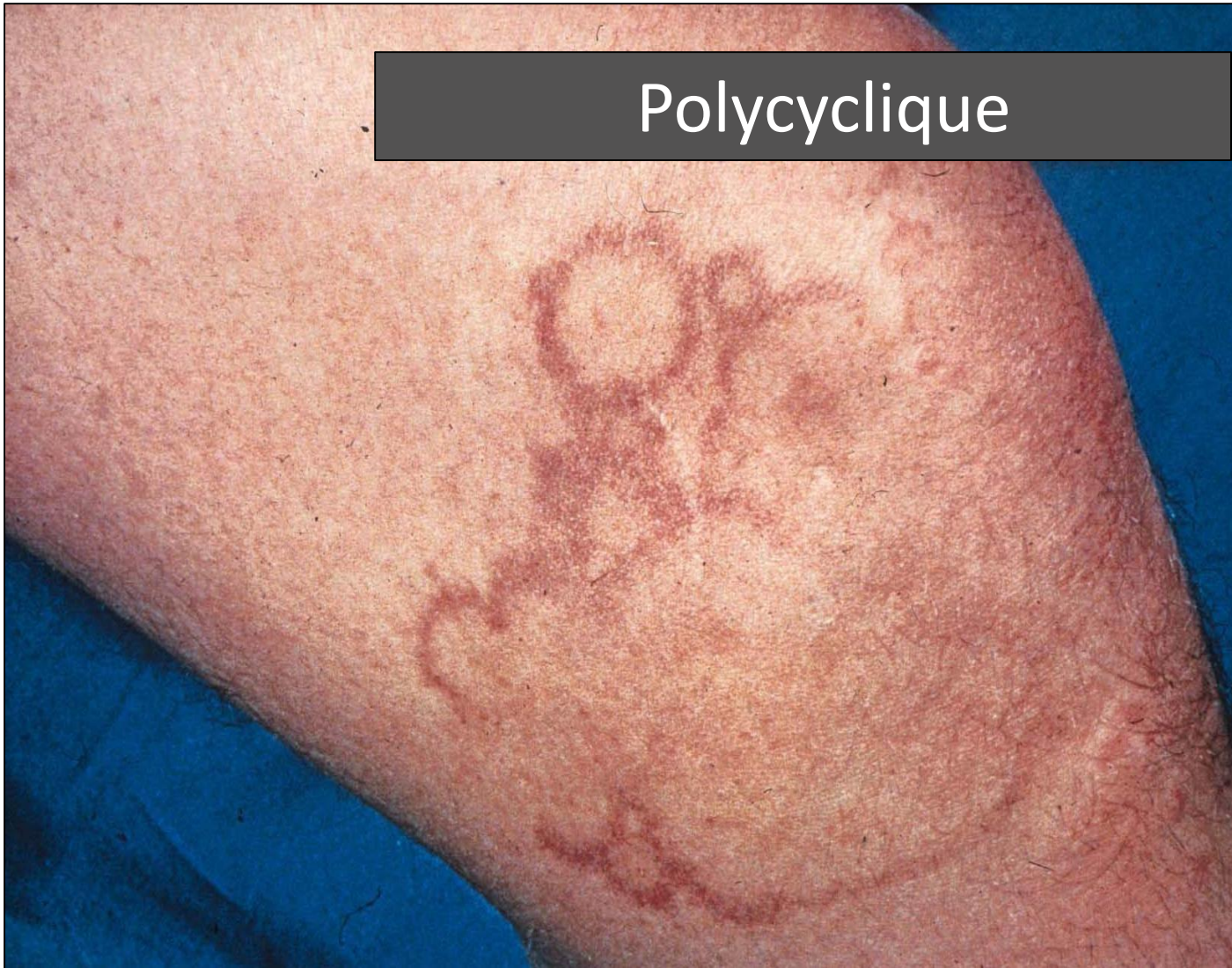


Psoriasis

Annulaire



Polycyclique





Linéaire

Linéaire

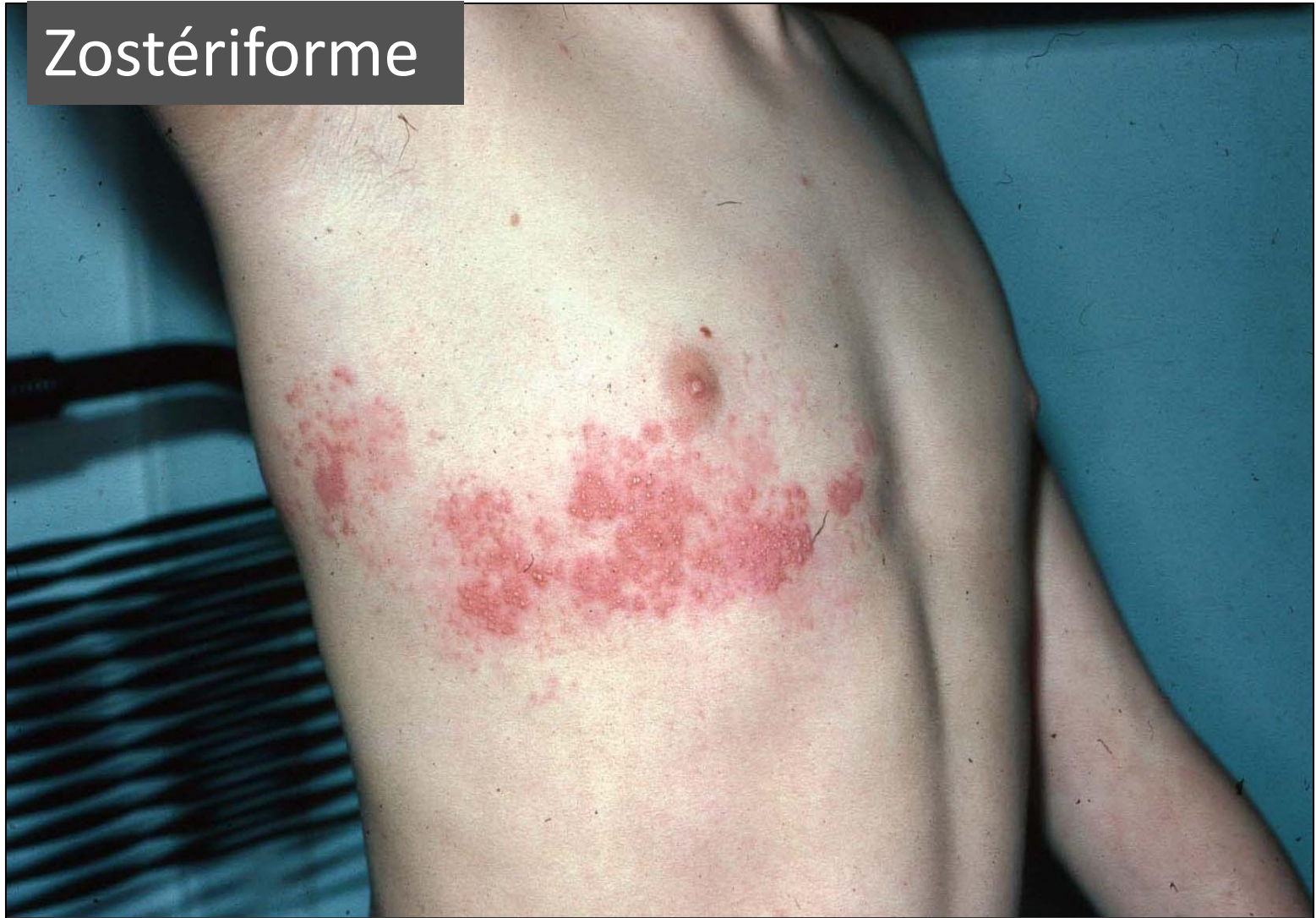
Phénomène isomorphique
de Koebner



Herpétiforme



Zostériforme



Réticulé



Serpigineux



Synthèse clinique systématique

1. Lésion élémentaire

2. Groupement

3. Topographie

TOPOGRAPHIE

La topographie, la distribution et l'étendue

Le lieu d'apparition peut être évocateur (les zones découvertes évoquent un déclenchement par le soleil) au cours des photodermatoses

Selon l'étendue, généralisée ou localisée, des groupes de diagnostics peuvent être évoqués

Le siège des lésions, leur caractère symétrique (vitiligo) leur topographie élective : zones déclives (purpura vasculaire), plis de flexion (eczéma atopique), sont aussi des arguments d'orientation utiles pour de nombreuses affections





























3- L'enquête anamnésique plus orientée :

La notion de prurit : parmi les rares signes fonctionnels, le prurit à une valeur d'orientation indiscutable. Le prurit peut être au premier plan et entraîner dans des dermatoses sévères une grave altération de la qualité de vie

L'environnement du patient : quelle est sa profession ? vit-il en milieu urbain ou à la campagne ? est-il en contact avec des animaux domestiques ? vit-il en collectivité ?...

Les antécédents familiaux : outre la notion galvaudée de "terrain allergique familial", l'enquête familiale doit être abordée systématiquement en cas d'une suspicion de dermatose congénitale

4- L'examen clinique général :

Chez un patient porteur d'une dermatose, l'examen cutané est indispensable mais jamais suffisant. L'examen général, reste systématique

Dans un grand nombre de cas, l'analyse des lésions cutanées permet, d'aboutir d'emblée à un diagnostic ou un groupe de diagnostic. Cette étape se montre cependant insuffisante dès que le symptôme est peu discriminant (c'est le cas des tumeurs par exemple) ou bien que le mécanisme n'est pas univoque (lésions bulleuses)

Des explorations paracliniques s'avèrent alors indispensables, soit pour compléter l'étude morphologique à l'échelon du tissu, grâce à l'histologie, ou bien pour aborder le mécanisme lésionnel, par des examens bactériologiques, virologiques ou immunologiques